

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PELATIHAN PENGELOLAAN OBAT ANTIHIPERTENSI SECARA

BENAR KEPADA ANGGOTA PKK KELURAHAN GAYAMSARI



TIM PENGABDIAN

apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm	NIDN/NIP: 0615039301 / 07051973
apt. Ferika Indrasari, S. Farm., M.H	NIDN/NIP: 0628058901 / 070715014
apt. Odilia Dea Christina, M. Farm	NIDN/NIP: 0621049403 / 07092099
apt. Margareta Retno P., M.Sc	NIDN/NIP: 07092098 / 0617107902
Ayu Atsna Shifa	NIM : A1232005
Tasya Dwi Ariyani	NIM : A1232022

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

SEMARANG

TAHUN 2024

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat : **Pelatihan Pengelolaan Obat Antihipertensi
Secara Benar Kepada Anggota PKK Kelurahan Gayamsari**

Ketua Pengabdi

Nama Lengkap : apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm
NIDN/NIP : 0615039301/07051973
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : DIII-Farmasi
Nomor HP : 085336094055
Alamat email : retheleonora@gmail.com

Anggota Pengabdi (1)

Nama Lengkap : apt. Ferika Indrasari, S. Farm., M.H
NIDN/NIP : 0628058901 / 070715014
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Anggota Pengabdi (2)

Nama Lengkap : apt. Odilia Dea Christina, M. Farm
NIDN/NIP : 0621049403 / 07092099
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Anggota Pengabdi (3)

Nama Lengkap : apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN/NIP : 07092098 / 0617107902
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Anggota Pengabdi (4)

Nama Lengkap : Ayu Atsna Shifa
NIM : A1232005
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Anggota Pengabdi (5)

Nama Lengkap : Tasya Dwi Ariyani
NIM : A1232022
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Biaya Pengabdian

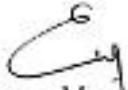
: Rp 3.250.000,00

Semarang, 20 Mei 2024

Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat,

Menyetujui,
Ketua LPPM

apt. Ayu Dina Soehana, M. Pharm.Sci
NIDN. 0611038705


apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm
NIDN: 0615039301

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera


apt. Rizky Ardan H. Sawal, M. Farm
NIDN: 0620029301


DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1. Analisis Situasi.....	4
2. Identifikasi Masalah	5
3. Tujuan Kegiatan	7
4. Manfaat Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
1. Prevalensi Dan Dampak Hipertensi	9
2. Pengobatan Hipertensi.....	10
3. Pendidikan Kesehatan Dan Keberhasilan Pengelolaan Hipertensi	12
4. Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Melalui Pelatihan.....	14
BAB III METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
A. Tempat Dan Waktu Pengabdian.....	16
B. Jumlah Peserta Pengabdian	16
C. Metode Kegiatan	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
BAB V KESIMPULAN.....	27
BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.....	27
A. Alokasi Anggaran PKM.....	27
B. Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat	28
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas (Sumartini *et al.*, 2019). Hipertensi juga merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, adalah kondisi medis kronis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat secara konsisten di atas nilai normal. Ini merupakan salah satu faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung.

Menurut data kesehatan, prevalensi hipertensi di kalangan lansia di Indonesia terus meningkat. Faktor gaya hidup, pola makan, dan perubahan demografi memainkan peran dalam peningkatan ini (La Ode Alifariki, 2020). Prevalensi hipertensi secara global saat ini sebesar 22% dari total jumlah penduduk dunia (Musa *et al.*, 2021). Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia menurut hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan 44,1% sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2%. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun 31,6%, umur 45-54 tahun 45,3%, dan umur 55-64 tahun 55,2%. Prevalensi hipertensi akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 nanti, sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hipertensi, khususnya di tingkat komunitas, Kelurahan Gayamsari telah menginisiasi program pelatihan untuk anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi para anggota PKK dalam mengelola obat antihipertensi secara benar.

Anggota PKK memainkan peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya sendiri tetapi juga berperan aktif dalam menyebarkan informasi kesehatan yang penting kepada komunitas yang lebih luas. Dengan bekal pengetahuan yang tepat, anggota PKK dapat membantu meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan hipertensi yang benar di

lingkungan mereka, sehingga berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pelatihan ini akan mencakup materi mengenai pentingnya pengelolaan tekanan darah, jenis-jenis obat antihipertensi, cara penggunaan yang benar, serta bagaimana memonitor tekanan darah secara rutin. Selain itu, akan disampaikan juga informasi mengenai perubahan gaya hidup yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan hipertensi, seperti diet sehat, aktivitas fisik, dan pengendalian stres.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan anggota PKK Kelurahan Gayamsari dapat menjadi role model dan sumber informasi yang handal dalam upaya pencegahan dan pengelolaan hipertensi di komunitas mereka. Pelatihan ini bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan individu, tetapi juga untuk membangun jaringan dukungan yang dapat mendorong perubahan positif dalam pengelolaan kesehatan di tingkat lokal.

2. Identifikasi Masalah

Pelatihan pengelolaan obat antihipertensi bagi anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Gayamsari merupakan inisiatif penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait manajemen hipertensi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif, beberapa masalah perlu diidentifikasi dan diatasi. Berikut adalah beberapa masalah utama yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan ini:

a) Kurangnya Pengetahuan Dasar tentang Hipertensi dan Pengobatannya.

- i. Banyak anggota PKK mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hipertensi, faktor risikonya, dan konsekuensi kesehatannya. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan obat antihipertensi yang tepat.
- ii. Pengetahuan yang terbatas mengenai jenis-jenis obat antihipertensi, mekanisme kerjanya, dan potensi efek samping dapat menghambat kemampuan anggota PKK untuk memberikan edukasi yang akurat kepada komunitas mereka.

b) Kepatuhan Terhadap Pengobatan

- i. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hipertensi adalah kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Anggota PKK perlu memahami pentingnya kepatuhan terhadap obat untuk mencegah komplikasi, namun mereka juga perlu belajar cara mengatasi hambatan kepatuhan yang sering dihadapi pasien.

- ii. Faktor-faktor seperti efek samping obat, biaya pengobatan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya penggunaan obat secara terus-menerus dapat mempengaruhi kepatuhan.
- c) Akses Terbatas ke Sumber Daya dan Informasi
 - i. Anggota PKK mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk memberikan edukasi yang tepat mengenai pengelolaan hipertensi.
 - ii. Kurangnya bahan pelatihan yang mudah dipahami dan diterapkan dapat menjadi kendala dalam penyampaian informasi yang efektif.
- d) Tingkat Literasi Kesehatan yang Bervariasi. Tingkat literasi kesehatan yang berbeda-beda di antara anggota PKK dapat mempengaruhi efektivitas pelatihan. Beberapa anggota mungkin memerlukan pendekatan yang lebih sederhana dan lebih banyak dukungan untuk memahami materi pelatihan.
- e) Perubahan Gaya Hidup dan Dukungan Sosial
 - i. Selain pengelolaan obat, perubahan gaya hidup seperti diet sehat, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres sangat penting dalam pengelolaan hipertensi. Anggota PKK perlu dilatih untuk memotivasi dan mendukung komunitas mereka dalam menerapkan perubahan ini.
 - ii. Keterlibatan keluarga dan komunitas dalam mendukung perubahan gaya hidup juga merupakan tantangan yang perlu diatasi.
- f) Monitoring dan Evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pelatihan ini memberikan hasil yang diinginkan. Tanpa monitoring yang baik, sulit untuk menilai apakah anggota PKK telah menguasai keterampilan yang diperlukan dan apakah mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam komunitas mereka.

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, program pelatihan dapat dirancang secara lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan nyata anggota PKK Kelurahan Gayamsari. Solusi yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan akan membantu memastikan keberhasilan pelatihan ini dalam meningkatkan pengelolaan hipertensi di tingkat komunitas.

3. Tujuan Kegiatan

1. Peningkatan Pengetahuan: Meningkatkan pemahaman anggota PKK tentang jenis-jenis obat antihipertensi, mekanisme kerja, dosis yang tepat, dan efek samping yang mungkin timbul.
2. Pengembangan Keterampilan Praktis: Meningkatkan keterampilan praktis anggota PKK dalam melakukan pengukuran tekanan darah dengan benar, memantau efek samping obat, dan memberikan dukungan serta edukasi kepada lansia dalam manajemen hipertensi.
3. Peningkatan Kesadaran akan Kepentingan Kepatuhan: Menyadarkan anggota PKK akan pentingnya kepatuhan pasien hipertensi terhadap pengobatan. Memahami bahwa kepatuhan adalah faktor kunci dalam mencapai kontrol tekanan darah yang baik.
4. Penyediaan Informasi yang Akurat: Menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang obat antihipertensi, termasuk panduan pemantauan efek samping, interaksi obat, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat.
5. Pengembangan Keterampilan Komunikasi: Meningkatkan keterampilan komunikasi anggota PKK agar mereka dapat mengkomunikasikan informasi tentang manajemen hipertensi dengan jelas dan efektif kepada lansia dan keluarganya.
6. Penguatan Peran Posyandu Lansia: Memberdayakan anggota PKK Lansia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendeteksi, memantau, dan mendukung lansia dalam pengelolaan hipertensi di tingkat masyarakat.

4. Manfaat Kegiatan

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kelurahan Gayamsari dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik kepada anggotanya.
2. Meningkatkan Kepatuhan Pasien: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen obat antihipertensi, diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan pasien, yang dapat membawa manfaat besar dalam pengendalian tekanan darah.
3. Pencegahan Komplikasi: Mengurangi risiko komplikasi yang disebabkan oleh hipertensi dengan meningkatkan pemantauan dan manajemen yang efektif.
4. Peningkatan Literasi Kesehatan Masyarakat: Memberikan kontribusi pada peningkatan literasi kesehatan masyarakat dengan menyediakan informasi yang dapat dimengerti dan diakses oleh lansia dan anggota masyarakat lainnya.

5. Pemberdayaan Komunitas: Memperkuat peran Ibu PKK sebagai pusat pemberdayaan komunitas dalam upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit, khususnya hipertensi.
6. Peningkatan Keberlanjutan Program Posyandu: Dengan memberdayakan anggota PKK Lansia, pelatihan ini dapat meningkatkan keberlanjutan program Posyandu di tingkat masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Prevalensi Dan Dampak Hipertensi

Menurut studi oleh *World Health Organization (WHO)*, hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang signifikan. Prevalensi hipertensi terus meningkat di seluruh dunia dan berkontribusi pada beban penyakit kardiovaskular yang tinggi. Data ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan pemahaman dan manajemen hipertensi di tingkat masyarakat (Monica *et al.*, 2019).

Hipertensi juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi yang merupakan suatu kondisi dimana pembuluh darah mengalami peningkatan tekanan secara terus-menerus. Darah dialirkan dari jantung ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Setiap kali jantung berdetak, jantung memompa darah ke dalam pembuluh darah. Tekanan darah diciptakan oleh kekuatan darah yang mendorong dinding pembuluh darah (arteri) saat dipompa oleh jantung. Semakin tinggi tekanannya, semakin keras jantung harus memompa (Ardiana, 2022).

Hipertensi adalah kondisi medis yang serius dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal dan penyakit lainnya. Hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia, dengan lebih dari 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita - lebih dari satu miliar orang - mengalami kondisi ini. Beban hipertensi dirasakan secara tidak proporsional di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana dua pertiga kasus ditemukan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan faktor risiko pada populasi tersebut dalam beberapa dekade terakhir (Shaumi & Achmad, 2019).

Banyak orang dengan hipertensi tidak merasakan gejalanya dan mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah. Gejalanya dapat berupa sakit kepala di pagi hari, mimisan, irama jantung yang tidak teratur, perubahan penglihatan, dan telinga berdengung. Bentuk yang lebih parah dapat berupa kelelahan, mual, muntah, kebingungan, kegelisahan, nyeri dada, dan tremor otot. Jika tidak diobati, hipertensi dapat menyebabkan nyeri dada yang menetap (disebut juga angina), serangan jantung, gagal jantung, dan detak jantung yang tidak teratur, yang dapat menyebabkan kematian mendadak (Adrian, 2019).

Hipertensi juga dapat menyebabkan stroke dengan menyumbat atau memecahkan arteri yang memasok darah dan oksigen ke otak, serta kerusakan ginjal, yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada jantung dengan mengeraskan arteri dan mengurangi aliran darah dan oksigen ke jantung. Mendeteksi hipertensi dilakukan dengan tes tekanan darah yang cepat dan tanpa rasa sakit. Hal ini dapat dilakukan di rumah, tetapi seorang ahli kesehatan dapat membantu menilai risiko atau kondisi terkait (Yonata & Pratama, 2016).

Mengurangi faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah cara terbaik untuk mencegah hipertensi dan penyakit jantung, otak, ginjal, dan organ-organ lainnya. Faktor-faktor ini termasuk diet yang tidak sehat (konsumsi garam yang berlebihan, diet tinggi lemak jenuh dan lemak trans, rendahnya asupan buah dan sayuran), kurangnya aktivitas fisik, konsumsi tembakau dan alkohol, dan kelebihan berat badan atau obesitas (*Livana et al.*, 2017).

Ada juga faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, termasuk riwayat hipertensi dalam keluarga, usia di atas 65 tahun, dan penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit ginjal. Menghindari faktor risiko diet dan perilaku menjadi sangat penting bagi mereka yang memiliki faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau faktor risiko keturunan (*Dismiantoni et al.*, 2020).

Hipertensi dapat dikelola dengan mengurangi dan mengelola stres mental, memeriksa tekanan darah secara teratur dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional, mengobati tekanan darah tinggi dan mengelola kondisi medis lainnya. Menghentikan penggunaan tembakau dan penggunaan alkohol yang berbahaya, serta memperbaiki pola makan dan olahraga, dapat membantu mengurangi gejala dan faktor risiko hipertensi (*Gunawan et al.*, 2020).

2. Pengobatan Hipertensi

Pengobatan Farmakologi dan Non-Farmakologi untuk Mengobati Hipertensi

Pengelolaan hipertensi melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pengobatan farmakologi (obat-obatan) dan non-farmakologi (perubahan gaya hidup). Kedua pendekatan ini sering digunakan bersama-sama untuk mencapai kontrol tekanan darah yang optimal dan mencegah komplikasi.

- a) Pengobatan Farmakologi. Pengobatan farmakologi untuk hipertensi melibatkan penggunaan berbagai jenis obat yang bekerja melalui mekanisme berbeda untuk menurunkan tekanan darah. Berikut adalah beberapa kelas obat antihipertensi yang umum digunakan:

i. Diuretik

- 1) Thiazide diuretics: Seperti hydrochlorothiazide dan chlorthalidone. Mereka membantu ginjal mengeluarkan natrium dan air, yang mengurangi volume darah dan menurunkan tekanan darah.
- 2) Loop diuretics: Seperti furosemide. Biasanya digunakan pada pasien dengan gagal jantung atau penyakit ginjal kronis.
- 3) Potassium-sparing diuretics: Seperti spironolactone. Sering digunakan bersama diuretik lain untuk mencegah kehilangan kalium yang berlebihan.

ii. Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitors

Contoh: lisinopril, enalapril. Obat ini mencegah pembentukan angiotensin II, yang menyebabkan vasokonstriksi dan retensi natrium.

iii. Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs)

Contoh: losartan, valsartan. Obat ini menghalangi reseptor angiotensin II, mencegah efek vasokonstriktor dan retensi natrium.

iv. Calcium Channel Blockers

Contoh: amlodipine, nifedipine. Obat ini mencegah masuknya kalsium ke dalam sel-sel otot jantung dan pembuluh darah, menyebabkan relaksasi dan vasodilatasi.

v. Beta Blockers

Contoh: metoprolol, atenolol. Obat ini mengurangi denyut jantung dan output jantung, serta menghambat pelepasan renin oleh ginjal.

vi. Alpha Blockers

Contoh: prazosin, doxazosin. Obat ini mengurangi resistensi vaskular dengan menghambat reseptor alpha-adrenergik di arteri.

vii. Central-acting Agents

Contoh: clonidine, methyldopa. Obat ini bekerja di otak untuk menurunkan sinyal saraf yang menyebabkan vasokonstriksi.

viii. Direct Vasodilators

Contoh: hydralazine, minoxidil. Obat ini langsung melebarkan pembuluh darah, mengurangi resistensi vaskular.

- b) Pengobatan Non-Farmakologi. Pendekatan non-farmakologi berfokus pada perubahan gaya hidup yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa strategi non-farmakologi yang efektif

i. Diet Sehat

- 1) Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension): Diet ini tinggi buah, sayuran, biji-bijian, dan produk susu rendah lemak. Juga mengandung sedikit lemak jenuh, kolesterol, dan natrium
- 2) Pengurangan Natrium. Membatasi asupan garam hingga kurang dari 2.300 mg per hari, atau idealnya hingga 1.500 mg per hari untuk individu tertentu.
- 3) Meningkatkan Asupan Kalium. Mengonsumsi makanan kaya kalium seperti pisang, kentang, dan sayuran hijau dapat membantu menurunkan tekanan darah.

ii. Aktivitas Fisik

- 1) Olahraga Aerobik: Aktivitas seperti berjalan, jogging, bersepeda, atau berenang selama setidaknya 150 menit per minggu dapat membantu menurunkan tekanan darah.
- 2) Latihan Kekuatan: Melakukan latihan kekuatan setidaknya dua kali seminggu juga bermanfaat.

iii. Pengendalian Berat Badan. Menurunkan berat badan berlebih dapat secara signifikan menurunkan tekanan darah. Bahkan penurunan berat badan yang sedikit (5-10% dari berat badan) dapat memberikan manfaat kesehatan yang besar.

iv. Pengendalian Stres. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam dapat membantu mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah.

v. Pembatasan Alkohol. Mengurangi konsumsi alkohol hingga tidak lebih dari satu minuman per hari untuk wanita dan dua minuman per hari untuk pria.

vi. Berhenti Merokok. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak dinding arteri. Berhenti merokok adalah langkah penting dalam pengelolaan hipertensi.

vii. Pola Tidur yang Baik. Tidur yang cukup dan berkualitas baik penting untuk kesehatan kardiovaskular. Gangguan tidur seperti sleep apnea juga perlu diatasi.

Pengobatan hipertensi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Kombinasi antara terapi farmakologi dan perubahan gaya hidup yang tepat dapat membantu mengendalikan tekanan darah dan mengurangi risiko komplikasi. Edukasi dan dukungan yang tepat bagi pasien sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dalam pengelolaan hipertensi.

3. Pendidikan Kesehatan Dan Keberhasilan Pengelolaan Hipertensi

Studi oleh Osamor dan Owumi menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan yang baik adalah kunci dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan dan pengelolaan

hipertensi. Pelatihan yang fokus pada memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas intervensi (Osamor & Owumi, n.d.).

Pendidikan kesehatan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan hipertensi. Ini melibatkan penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman yang mendalam kepada individu, termasuk pasien dan anggota masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka. Berikut adalah lebih banyak penjelasan tentang hubungan antara pendidikan kesehatan dan keberhasilan pengelolaan hipertensi:

- a) **Pemahaman tentang Hipertensi:** Pendidikan kesehatan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu hipertensi, penyebabnya, dan dampaknya pada tubuh. Pasien yang memahami kondisi mereka cenderung lebih terlibat dalam manajemen hipertensi.
- b) **Peran Gaya Hidup Sehat:** Pendidikan kesehatan membimbing individu untuk mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk pola makan seimbang, olahraga teratur, dan menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Gaya hidup sehat dapat membantu mengelola tekanan darah dan mengurangi risiko komplikasi (Laili & Purnamasari, 2019).
- c) **Pemahaman tentang Obat-Obatan:** Informasi tentang obat antihipertensi, dosis yang diperlukan, dan efek samping potensial sangat penting. Pendidikan kesehatan dapat membantu pasien memahami manfaat dan risiko pengobatan, serta mengatasi kekhawatiran atau ketidaknyamanan terkait penggunaan obat.
- d) **Kepatuhan Pengobatan:** Pendidikan kesehatan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pada rencana pengobatan. Pasien yang memahami betapa krusialnya kepatuhan cenderung lebih disiplin dalam mengikuti petunjuk pengobatan dan menjalani pemeriksaan rutin (Tumundo *et al.*, 2021).
- e) **Pengukuran Diri:** Pendidikan kesehatan memberdayakan pasien untuk melakukan pengukuran tekanan darah sendiri di rumah. Kemampuan ini dapat membantu pasien dan anggota keluarga memantau tekanan darah secara teratur dan memberikan informasi berharga kepada profesional kesehatan.
- f) **Manajemen Stres:** Pengetahuan tentang teknik manajemen stres dan relaksasi dapat membantu pasien mengelola faktor-faktor psikologis yang dapat memengaruhi tekanan darah. Pendidikan kesehatan dapat memberikan strategi untuk mengurangi stres sehari-hari (Setyo *et al.*, 2022).

- g) Pemahaman Tentang Komplikasi dan Tanda Bahaya: Pasien yang mendapatkan pendidikan kesehatan akan lebih sadar akan potensi komplikasi yang terkait dengan hipertensi. Mereka juga akan memahami tanda-tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis segera.
- h) Dukungan Keluarga dan Komunitas: Pendidikan kesehatan melibatkan keluarga dan komunitas sebagai pendukung pasien. Keluarga yang teredukasi dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan hipertensi.
- i) Penyesuaian Gaya Hidup: Berdasarkan pemahaman yang diberikan melalui pendidikan kesehatan, pasien dapat menyesuaikan gaya hidup mereka untuk meminimalkan risiko terkait hipertensi. Ini termasuk menghindari makanan berlemak tinggi, mengatur konsumsi garam, dan menjaga berat badan yang sehat (Aprillia, 2020).
- j) Pemberdayaan Pasien: Keberhasilan pengelolaan hipertensi sangat bergantung pada pendidikan kesehatan yang efektif. Memberikan informasi yang tepat pada waktu yang tepat dan melibatkan pasien secara aktif dalam perawatan mereka sendiri adalah kunci untuk mencapai hasil yang baik dalam manajemen hipertensi (Laelasari *et al.*, 2019).

4. Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Melalui Pelatihan

Model pelatihan untuk kader kesehatan merupakan suatu pendekatan sistematis yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan bagi para kader kesehatan agar dapat menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif. Kader kesehatan biasanya merupakan individu yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan kesehatan primer di tingkat masyarakat. Model pelatihan yang efektif untuk kader kesehatan, termasuk anggota PKK, dapat ditemukan dalam penelitian oleh Rahayu dan Pratiwi. Penelitian ini menyoroti pentingnya menyusun kurikulum pelatihan yang komprehensif, termasuk materi tentang manajemen obat dan keterampilan komunikasi (Rahayu *et al.*, 2018). Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang model pelatihan untuk kader kesehatan:

- a) Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Langkah pertama dalam merancang model pelatihan adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik para kader kesehatan. Ini dapat melibatkan evaluasi kompetensi mereka, analisis tugas-tugas mereka, dan pemahaman mendalam tentang konteks kesehatan masyarakat setempat.

- b) Tujuan Pelatihan yang Jelas: Tetapkan tujuan pelatihan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan kader kesehatan dan mencakup peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan perubahan sikap yang diinginkan.
- c) Model Pembelajaran Aktif: Pilih model pembelajaran yang aktif dan interaktif. Melibatkan para peserta secara langsung dalam kegiatan-kegiatan praktis, diskusi kelompok, dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelatihan.
- d) Kurikulum yang Komprehensif: Rancang kurikulum pelatihan yang komprehensif, mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan kesehatan dasar, keterampilan teknis, komunikasi efektif, dan aspek-aspek psikososial yang relevan dengan peran kader kesehatan.
- e) Pelatihan Berbasis Keterampilan: Fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam pelayanan kesehatan primer. Misalnya, kader kesehatan dapat dilatih dalam pengukuran tekanan darah, pemberian imunisasi, atau edukasi kesehatan kepada masyarakat.
- f) Penggunaan Teknologi Pendidikan: Manfaatkan teknologi pendidikan seperti e-learning, simulasi komputer, atau aplikasi mobile untuk mendukung proses pembelajaran. Ini dapat membantu mencapai skala yang lebih besar dan memfasilitasi akses ke materi pelatihan di berbagai lokasi.
- g) Pendekatan Berbasis Masalah: Gunakan pendekatan berbasis masalah yang memungkinkan para kader kesehatan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat secara aktif. Ini dapat meningkatkan pemahaman kontekstual dan penerapan praktis pengetahuan yang diperoleh.
- h) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Sertakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan memantau kemajuan para kader kesehatan selama dan setelah pelatihan, Anda dapat menilai efektivitas program dan membuat perubahan yang diperlukan.
- i) Partisipasi Komunitas: Melibatkan komunitas dalam merancang dan memberikan pelatihan. Partisipasi komunitas dapat memastikan bahwa pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diterapkan secara efektif.
- j) Pemberdayaan Kader Kesehatan: Dengan merancang model pelatihan yang sesuai dan efektif, kader kesehatan dapat menjadi aset berharga dalam pemberian pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, termasuk dalam pengelolaan hipertensi dan upaya pencegahan penyakit lainnya.

BAB III

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tempat Dan Waktu Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Kelurahan Gayamsari, Jl. Slamet Riyadi, No. 4, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah.

B. Jumlah Peserta Pengabdian

Jumlah peserta sekitar 30-50 orang yaitu Ibu-Ibu PKK di Jl. Slamet Riyadi, Kel. Gayamsari, Kec. Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah.

C. Metode Kegiatan

Pelatihan pengelolaan obat antihipertensi kepada anggota PKK di Kelurahan Gayamsari dapat dilakukan melalui berbagai metode untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang benar. Berikut adalah beberapa metode yang bisa digunakan:

1. Pendekatan Teori:

- a. Pemberian Materi: Materi yang diberikan mencakup penjelasan tentang hipertensi, obat antihipertensi, pengelolaan dosis, efek samping, dan pentingnya konsistensi dalam pengobatan.
- b. Presentasi: presentasi visual, seperti slide, grafik, atau video pendek, untuk membantu anggota PKK memahami informasi dengan lebih baik.

2. Demonstrasi Praktis:

- a. Simulasi Pemberian Obat: Melibatkan peserta dalam simulasi pemberian obat antihipertensi kepada pasien. Ini dapat membantu mereka memahami teknik yang benar dan pentingnya memastikan pasien mengonsumsi obat sesuai petunjuk.
- b. Diskusi dan Tanya Jawab: Sesi Tanya Jawab; Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan pertanyaan mereka. Ini dapat membantu mengklarifikasi konsep dan merespon kebutuhan individu.

3. Studi Kasus:

- a. Analisis Kasus Nyata: Mendiskusikan kasus nyata tentang pasien hipertensi dan bagaimana pengelolaan obat dapat mempengaruhi kondisi pasien tersebut. Hal ini dapat membantu memahami konteks praktis dari pelatihan.

4. Pembuatan Materi Edukasi: Proyek Kelompok: Meminta anggota PKK untuk bekerja dalam kelompok dan menciptakan materi edukasi seperti leaflet, brosur, atau poster tentang pengelolaan obat antihipertensi. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka dan dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lebih luas.
5. Pemantauan dan Evaluasi:
 - a. Ujian Keterampilan: Mengadakan ujian keterampilan setelah pelatihan untuk memastikan bahwa anggota PKK dapat mengelola obat antihipertensi dengan benar.
 - b. Pemantauan Berkelanjutan: Menyelenggarakan sesi pemantauan reguler untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan terus ditingkatkan dan diterapkan dengan baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dari tiga tugas utama di perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini bisa berupa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Dalam konteks ini, kegiatan tersebut berpotensi memberikan manfaat baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Mahasiswa dapat berbagi pengetahuan baru dan pengalaman sehari-hari kepada masyarakat, sementara masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari aplikasi praktis teori yang dipelajari mahasiswa di kampus. Misalnya, dalam kegiatan PkM seperti Pelatihan Pengelolaan Obat Antihipertensi yang benar kepada Anggota PKK di Kelurahan Gayamsari. Tujuan dilakukan kegiatan PkM adalah; untuk mengedukasi anggota PKK tentang pentingnya pengelolaan obat antihipertensi yang tepat, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada anggota PKK untuk mengelola obat antihipertensi dengan benar, dan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh anggota PKK.

Pengelolaan hipertensi sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia di mana hipertensi merupakan masalah kesehatan yang signifikan. Pusat Kesehatan Masyarakat (PKK) Kelurahan Gayamsari memainkan peran penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk memastikan pengelolaan hipertensi yang efektif, penting untuk mengedukasi petugas kesehatan tentang pengelolaan obat yang tepat. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali anggota PKK dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola obat antihipertensi dengan benar.

Pelatihan dilakukan di ruang serbaguna Kelurahan Gayamsari. Pelatihan ini dipimpin oleh Ketua dan Anggota Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) yang berprofesi sebagai dosen dan atau apoteker, sehingga memiliki keahlian dalam manajemen hipertensi. Pelatihan terdiri dari sesi teori dan diskusi mencakup topik-topik berikut: Definisi dan Prevalensi Hipertensi. Definisi dan prevalensi hipertensi dibahas, dengan menekankan pentingnya deteksi dini dan manajemen hipertensi. Pengobatan Antihipertensi meliputi berbagai jenis obat antihipertensi, mekanisme kerjanya, dan efek samping yang umum terjadi dijelaskan.

Pelatihan ini dievaluasi melalui penilaian sebelum (*Pre test*) dan sesudah pelatihan (*Post test*). Penilaian tersebut meliputi pertanyaan pilihan ganda dalam google form yang terangkum dalam sebuah kuesioner yang dapat dilihat pada gambar 1. Dengan pertanyaan

yang sama sebanyak 10 soal pilihan ganda, kuesioner ini akan dibagikan kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Gayamsari pada saat sebelum dan setelah kegiatan pengabdian.

The image displays two screenshots of a Google Form titled "Hipertensi". The top screenshot is the "Kuesioner Pre Test Pelatihan Pengelolaan Obat Anti hipertensi Yang Baik dan Benar". The bottom screenshot is the "Kuesioner Post Test Pelatihan Pengelolaan Obat Anti hipertensi Yang Baik dan Benar". Both forms have a header with the title "Hipertensi" in large red font. Below the title, there is a section labeled "Bagian 1 dari 3". The form contains a text area for "Nama Lengkap *" and a text area for "Teks jawaban singkat". The form also includes a "Kirim" button and a "Poin total: 14" indicator.

Gambar 1. Kuesioner *Pre Test* & *Post Test* Pada *Google Form*

Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi; Apa yang dimaksud dengan hipertensi; Berapa nilai tekanan darah yang dianggap sebagai hipertensi; Apa tujuan utama pengobatan anti hipertensi, Apa saja jenis obat yang biasa digunakan untuk mengobati hipertensi; Mengapa penting untuk mengikuti jadwal minum obat anti hipertensi yang telah ditentukan; Apa yang harus dilakukan jika seseorang melewatkan dosis obat anti hipertensi; Apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami efek samping yang tidak diinginkan setelah mengonsumsi obat anti hipertensi; Bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan obat antihipertensi; Apakah penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat dan suplemen

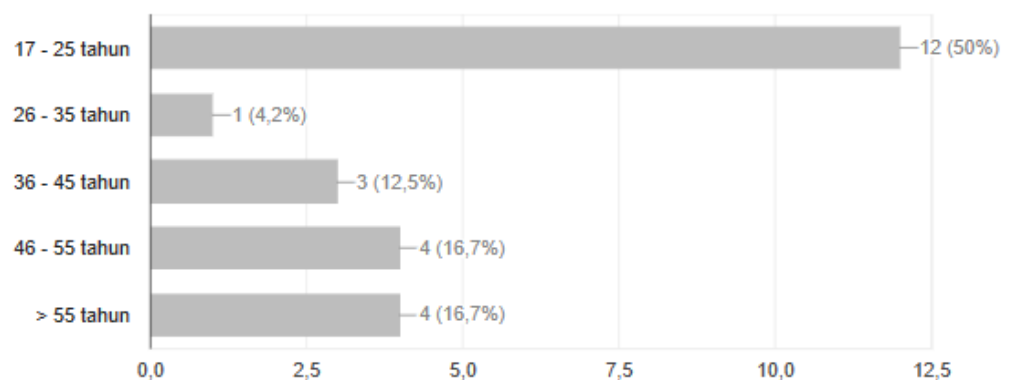
yang dikonsumsi sebelumnya saat mendapatkan resep obat anti hipertensi baru; dan Kapan sebaiknya melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur.

Distribusi karakteristik responden dalam kegiatan PkM ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang profil demografis dan sosial-ekonomi peserta. Informasi ini mencakup berbagai aspek seperti usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Memahami distribusi karakteristik ini sangat penting untuk menilai efektivitas program yang dijalankan serta untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi pengembangan intervensi lebih lanjut. Berikut ini adalah rincian distribusi karakteristik responden yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini yang dapat dilihat pada gambar 2.

Usia

[Salin](#)

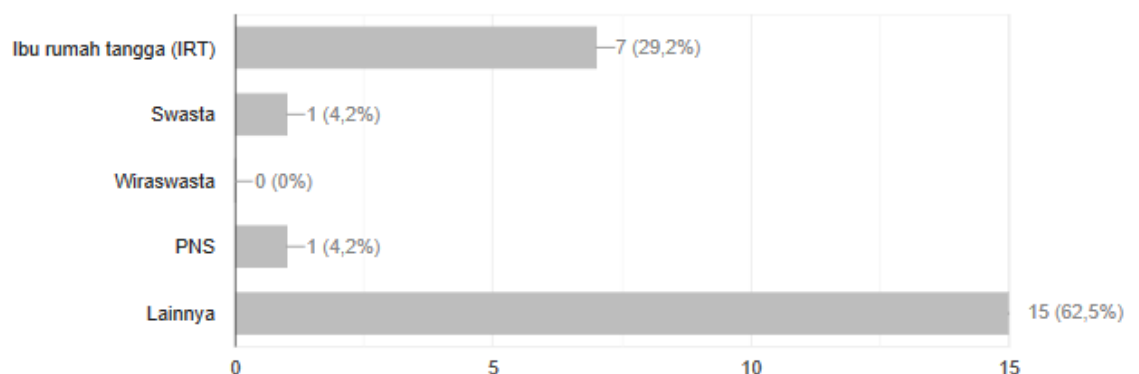
0 / 24 jawaban yang benar

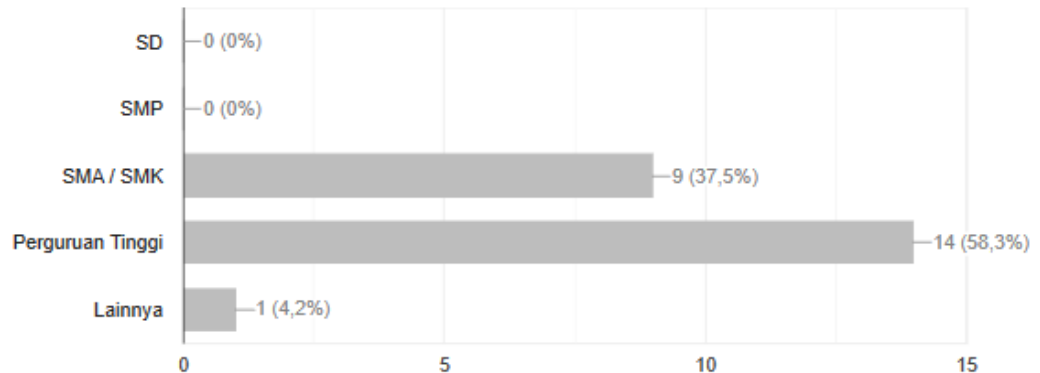


Pekerjaan

[Salin](#)

0 / 24 jawaban yang benar





Gambar 2. Distribusi Karakteristik Responden

Berdasarkan distribusi karakteristik responden pada gambar 2 menunjukkan bahwa usia, pekerjaan, dan pendidikan adalah faktor-faktor demografis yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan responden tentang pengolahan obat anti hipertensi yang benar. Meliputi;

1. Usia

- a. Pengalaman hidup dan kesehatan. Orang yang lebih tua mungkin memiliki lebih banyak pengalaman terkait kesehatan, baik dari segi pribadi maupun dari interaksi dengan sistem perawatan kesehatan. Mereka mungkin telah menerima lebih banyak informasi atau mengalami lebih banyak edukasi terkait penyakit kronis seperti hipertensi (Triningtyas & Muhayati, 2018).
- b. Penurunan kognitif. Sebaliknya, penurunan kognitif terkait usia dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memproses dan mengingat informasi baru (Marinda, 2020).
- c. Ketertarikan dan kepedulian. Individu yang lebih tua seringkali lebih peduli dengan masalah kesehatan karena mereka mungkin sudah mengalami atau berisiko mengalami kondisi terkait hipertensi, sehingga lebih termotivasi untuk belajar tentang pengolahan obat yang benar (Murty, 2022).

2. Pekerjaan

- a. Akses ke informasi. Jenis pekerjaan dapat menentukan sejauh mana seseorang memiliki akses ke informasi kesehatan. Misalnya, mereka yang bekerja di sektor kesehatan atau pekerjaan yang memberikan akses ke fasilitas kesehatan cenderung memiliki pengetahuan lebih baik tentang pengolahan obat (Widjanarko *et al.*, 2023).

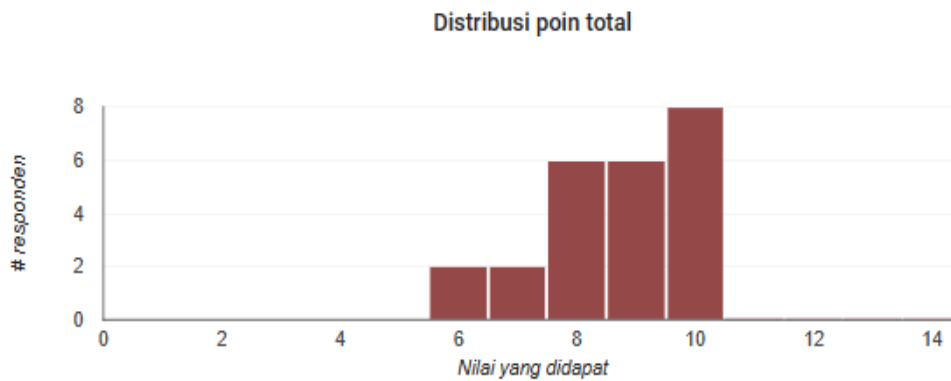
- b. Waktu dan kesempatan. Pekerjaan yang menuntut banyak waktu atau tenaga mungkin membatasi kesempatan seseorang untuk mengikuti edukasi kesehatan atau mencari informasi tambahan (Hamali & SS, 2023).
- c. Pendidikan formal dan informal di tempat kerja. Beberapa pekerjaan mungkin menawarkan pelatihan atau informasi terkait kesehatan sebagai bagian dari program kesejahteraan karyawan, yang bisa meningkatkan pengetahuan mereka (Darmawan *et al.*, 2021).

3. Pendidikan

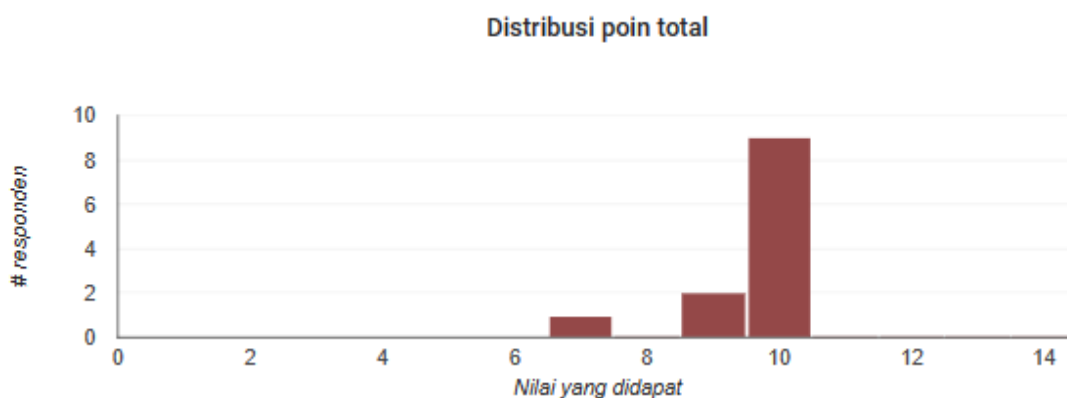
- a. Literasi kesehatan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya berhubungan dengan literasi kesehatan yang lebih baik, yang meliputi kemampuan untuk memahami informasi medis, instruksi pengobatan, dan manfaat serta risiko obat-obatan (Waliulu *et al.*, 2024).
- b. Kemampuan belajar. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki keterampilan belajar yang lebih baik, termasuk kemampuan untuk mencari, memahami, dan menerapkan informasi baru terkait kesehatan (Suardi, 2018).
- c. Akses ke sumber informasi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan akses yang lebih baik ke sumber informasi yang dapat dipercaya, seperti jurnal medis, situs web kesehatan yang terkemuka, dan layanan konsultasi kesehatan (Rumondang *et al.*, 2020).

Ketiga faktor ini seringkali saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Misalnya, individu yang berpendidikan tinggi mungkin cenderung memiliki pekerjaan yang memberikan akses lebih besar ke informasi kesehatan dan juga lebih mungkin untuk terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan literasi kesehatan. Demikian pula, usia yang lebih tua seringkali disertai dengan pengalaman yang lebih banyak, namun jika tidak didukung oleh pendidikan yang memadai, bisa jadi pengetahuan yang dimiliki masih kurang.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui *pre test* dan *post test* tentang pengelolaan obat antihipertensi yang baik dan benar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4. Evaluasi ini dilakukan untuk pengembangan program lebih lanjut serta membahas langkah-langkah tindak lanjut setelah program PkM selesai.



Gambar 3. Hasil *Pre Test* Kuesioner



Gambar 4. Hasil *Post Test* Kuesioner

Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata hasil *pre test* tingkat pengetahuan ibu-ibu PKK Kelurahan Gayamsari sebesar 8,67%. Sedangkan gambar 3 menunjukkan bahwa rata-rata hasil *post test* tingkat pengetahuan ibu-ibu PKK Kelurahan Gayamsari sebesar 9,58%. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi tersebut meliputi; pertama, Tingkat pendidikan ibu-ibu PKK bisa mempengaruhi pemahaman mereka tentang informasi kesehatan, termasuk pengolahan obat anti hipertensi. Literasi kesehatan yang rendah bisa menyebabkan pemahaman yang kurang memadai sebelum intervensi pendidikan dilakukan. Kedua, Cara penyampaian materi, media yang digunakan, serta kemampuan fasilitator dalam memberikan penjelasan bisa mempengaruhi pemahaman peserta. Metode interaktif seperti diskusi kelompok, demonstrasi, dan penggunaan alat bantu visual bisa meningkatkan efektivitas edukasi. Ketiga, Tingkat motivasi dan minat ibu-ibu PKK terhadap materi yang disampaikan bisa mempengaruhi seberapa besar mereka menyerap informasi. Peserta yang memiliki minat tinggi dan memahami pentingnya pengolahan obat anti hipertensi mungkin akan lebih memperhatikan dan mengingat informasi yang diberikan. Keempat, Pengalaman pribadi atau pengalaman anggota keluarga terkait dengan hipertensi dan pengobatannya bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan awal. Ibu-ibu yang sudah sering berinteraksi dengan

pengobatan hipertensi mungkin memiliki pengetahuan dasar yang lebih baik dibandingkan mereka yang belum pernah. Kelima, Ketersediaan sumber informasi kesehatan yang mudah diakses, seperti brosur, pamflet, atau media digital, juga dapat berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan. Akses informasi yang baik memungkinkan peserta untuk mengkaji ulang materi yang telah disampaikan. Keenam, Dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan. Diskusi dengan anggota keluarga atau teman yang memiliki pengetahuan serupa bisa membantu memperkuat pemahaman.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu peningkatan dari 8,67% pada pretest menjadi 9,58% pada posttest, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan meskipun relatif kecil. Hal ini menunjukkan adanya dampak dari intervensi edukasi yang dilakukan, namun juga mengindikasikan bahwa mungkin diperlukan metode pendidikan yang lebih efektif atau intensif untuk mencapai peningkatan pengetahuan yang lebih signifikan. Evaluasi lebih lanjut terhadap metode penyuluhan, materi yang disampaikan, dan pelibatan peserta bisa menjadi langkah selanjutnya untuk memperbaiki hasil edukasi kesehatan di masa depan.

Pada kegiatan PkM, baik saat penilaian pengetahuan pada *pre test-post test*, presentasi, maupun diskusi bersama peserta dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari sesi diskusi yang berlangsung selama kegiatan presentasi dan atau penyuluhan pengelolaan obat antihipertensi. Kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada gambar 5. Sedangkan leaflet Hipertensi dapat dilihat pada gambar 6.





Gambar 5. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Bersama Ibu-Ibu PKK Kelurahan Gayamsari

Apa Itu Hipertensi?

Hipertensi adalah kondisi medis yang ditandai dengan tekanan darah yang konstan tinggi pada dinding arteri.

Tekanan darah yang tinggi ini dapat menyebabkan beban berlebih pada jantung dan pembuluh darah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan masalah kesehatan lainnya.





Untuk informasi lebih lanjut atau pendaftaran, silakan hubungi:

1. apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm
2. apt. Ferika Indrasari, S. Farm., M.H
3. apt. Odilia Dea Christina, M.Farm
4. Tasya Dwi Ariyani
5. Ayu Atsna Shifa

Tempat Pelatihan

Kantor Kelurahan Gayamsari,
Jl. Slamet Riyadi No.4 50161
Semarang Jawa Tengah




Hipertensi (Darah Tinggi)



Pelatihan Pengelolaan Obat Antihipertensi Yang Baik dan Benar

📅 Kamis, 5 - Mei - 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi
Nusaputera Semarang
2024




Resiko Hipertensi dapat dikurangi dengan



Mengurangi konsumsi Garam
(Jangan Melebihi 1 Sendok
Teh Per Hari)



Melakukan aktivitas fisik teratur
(seperti Jalan kaki 3 km/ olahraga
someret per hari minimal 5x/minggu)



Tidak merokok dan
menghindari **Asap rokok**



Menghindari minuman
Beralkohol



Mempertahankan
Berat Badan **ideal**



Diet dengan Gizi
seimbang

Gejala-Gejala Hipertensi



Sakit Kepala



Susah Tidur



Mudah Lelah



Sesak Nafas



Mual dan Muntah



Nyeri Dada



Pandangan Mata Kabur



Pendarahan di Hidung

Jenis Hipertensi

Berdasarkan penyebab

1. **Hipertensi Premier (Essensial)**
Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya (90%)
2. **Hipertensi Sekunder**
Penyebabnya dapat ditentukan (10%) antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (Hipertiroid), penyakit kelenjar adrenal (Hiperadosteronisme), dll.

Penyebab Hipertensi



Stress



Keturunan



Merokok



Kegemukan/Obesitas



Kurang Beraktifitas



Kelainan Ginjal



Minum Air Keras



Usia

Gambar 6. Leaflet Hipertensi dalam Kegiatan PkM

BAB V

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berupa pelatihan pengelolaan obat antihipertensi yang baik dan benar telah dilaksanakan dengan sukses di Kelurahan Gayamsari. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu PKK mengenai pengolahan dan penggunaan obat antihipertensi yang tepat guna mengoptimalkan pengendalian hipertensi dan mencegah komplikasi yang lebih serius.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Skor pretest menunjukkan angka 8,67%, yang meningkat menjadi 9,58% pada posttest. Meskipun peningkatan ini relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari pelatihan terhadap pemahaman peserta tentang pengelolaan obat antihipertensi. Pelatihan pengelolaan obat antihipertensi yang baik dan benar telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK di Kelurahan Gayamsari. Untuk hasil yang lebih optimal, perlu adanya peningkatan dalam intensitas dan metode pelatihan, serta dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya edukasi kesehatan dalam komunitas untuk mencapai pengendalian hipertensi yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. J. (2019). Hipertensi esensial: diagnosis dan tatalaksana terbaru pada dewasa. *Cermin Dunia Kedokteran*, 46(3), 172–178.
- Aprillia, Y. (2020). Gaya Hidup dan Pola Makan Terhadap Kejadian Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(2), 1044–1050.
- Ardiana, M. (2022). *Buku Ajar Menangani Hipertensi*. Airlangga University Press.
- Darmawan, D., Sudrajat, I., Maulana, M. K. Z., & Febriyanto, B. (2021). Perencanaan Pengumpulan Data sebagai Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 71–88.
- Dismiantoni, N., Anggunan, A., Triswanti, N., & Kriswiastiny, R. (2020). Hubungan Merokok Dan Riwayat Keturunan Dengan Kejadian Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 30–36.
- Gunawan, A., Prahasanti, K., Utama, M. R., & Airlangga, M. P. (2020). Pengaruh komorbid hipertensi terhadap severitas pasien coronavirus disease 2019. *Jurnal Implementa Husada*, 1(2), 136–151.
- Hamali, A. Y., & SS, M. M. (2023). *Pemahaman manajemen sumber daya manusia*. Caps.
- La Ode Alifariki, S. K. (2020). *Epidemiologi Hipertensi: Sebuah Tinjauan Berbasis Riset*. Penerbit LeutikaPrio.
- Laelasari, E., Prasodjo, R. S., Cahyorini, C., Handayani, K., Wiryawan, Y., & Anwar, A. (2019). Model Intervensi Hipertensi Di Puskesmas Purwoyoso, Semarang. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 18(1), 15–26.
- Laili, N., & Purnamasari, V. (2019). Hubungan Modifikasi Gaya Hidup dengan Kualitas Hidup Pasien Hipertensi di UPTD PKM Adan Adan Gurah Kediri. *Jurnal Ilkes (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 10(1), 66–76.
- Livana, P. H., Ikhwan, M., & Hermanto, H. (2017). Hubungan Faktor Pemicu Hipertensi Dengan Kejadian Hipertensi. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), 8–18.
- Marinda, L. (2020). Teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan problematikanya pada anak usia sekolah dasar. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 13(1), 116–152.
- Monica, R. F., Adiputro, D. L., & Marisa, D. (2019). Hubungan Hipertensi dengan Penyakit Jantung Koroner pada Pasien Gagal Jantung di RSUD Ulin Banjarmasin. *Homeostasis*, 2(1), 121–124.
- Murty, A. I. (2022). *Psikologi Kesehatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Musa, E. C., Kesehatan, F., Universitas, M., Ratulangi, S., & Belakang, A. L. (2021). Status Gizi Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Kinilow Tomohon. *Sam Ratulangi Journal of Public Health*, 2(2).

- Osamor, P. E., & Owumi, B. E. (n.d.). *Factors Associated with Treatment Compliance in Hypertension in Southwest Nigeria*.
- Rahayu, N. W., Setiani, N., Putro, H. P., & Maureen, I. Y. (2018). The Impact of Undergraduate Program Developers and User Participation on the Quality of School Information System. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 24(2), 222–228. <https://doi.org/10.21831/jptk.v24i2.20267>
- Rumondang, A., Sudirman, A., & Sitorus, S. (2020). *Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen*. Yayasan Kita Menulis.
- Setyo, A., Isworo, A., & Ekowati, W. (2022). Manajemen Stress Psikologis untuk Pengendalian Tekanan Darah dengan Hipnoterapi Pada Kelompok Penderita Hipertensi RW I Mersi Kabupaten Banyumas. *Jurnal of Community Health Development*, 3(1), 7–14.
- Shaumi, N. R. F., & Achmad, E. K. (2019). Kajian literatur: faktor risiko hipertensi pada remaja di Indonesia. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 29(2), 115–122.
- Suardi, M. (2018). *Belajar & pembelajaran*. Deepublish.
- Sumartini, N. P., Zulkifli, Z., & Adhitya, M. A. P. (2019). Pengaruh senam hipertensi lansia terhadap tekanan darah lansia dengan hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Cakranegara Kelurahan Turida tahun 2019. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)*, 1(2), 47–55.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2018). *Mengenal lebih dekat tentang lanjut usia*. CV. Ae Media Grafika.
- Tumundo, D. G., Wiyono, W. I., & Jayanti, M. (2021). Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi Di Puskesmas Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Pharmacon*, 10(4), 1121–1128.
- Waliulu, Y. S., Sos, S., Kom, M. I., Marasabessy, N. B., ST, S., Rejo, S. S. T., Yuniarti, T., KM, S., Sudiadnyana, I. W., & Indarwati, S. K. M. (2024). *KOMUNIKASI KESEHATAN*. CV Rey Media Grafika.
- Widjanarko, W., Hadita, H., Saputra, F., & Cahyanto, Y. A. D. (2023). Determinasi Kemudahan Akses Informasi Bagi Keputusan Investasi Gen Z. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(4), 248–264.
- Yonata, A., & Pratama, A. S. P. (2016). Hipertensi sebagai faktor pencetus terjadinya stroke. *Jurnal Majority*, 5(3), 17–21.

L

A

M

P

I

R

A

N

1. Surat Tugas Kegiatan



SURAT TUGAS

No.: 057/STPM-LPPM/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.

Jabatan : Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Peran	Keterangan
1	apt. Eleonora Maryeta Toyo, M.Farm.	Ketua Pengabd	Dosen / NIDN 0615039301
2	apt. Odelia Dea Christina, M.Farm.	Dosen / NIDN 0621049403	Anggota
3	apt. Ferika Indrasari, S.Farm., MH.	Dosen / NIDN 0628058901	Anggota
4	apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc.	Dosen / NIDN 0617107902	Anggota
5	Ayu Atsna Shifa dan Tasya Dwi Ariyani	A1232005 dan A1232022	Anggota

Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan :

Judul : Pelatihan Pengelolaan Obat Antihipertensi Secara Benar Kepada
Anggota Posyandu Lansia Kelurahan Gayamsari

Tempat : Kelurahan Gayamsari

Hari/Tanggal : Minggu, 5 Mei 2024

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 03 May 2024

Ketua LPPM STIFERA



Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.

NIDN. 0611038705

2. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :
TEMPAT :
ACARA :

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA-TANGAN
1					1
2	Elena S.	P	Pokja IV	Jl. Majapahit 150/21	2
3	Ani Hariningsanti	P	PKK RW 03	Jl. Karanganyar 11	3
4	Retho K	P	Pokja II	Jl. Gajah Timur Dlm B	4
5	Ibu Sudaryati S	P	Jusel	Lampung kayu	5
6	St. Maryani	P	Pokja 4	Rt. 10/03	6
7	Kristiana	P	Pokja 4	RT 03/03	7
8	Sri Suprapti	P	Pokja 4	RT 03/03	8
9	Sri Mulyani	P		Aspol Kalduh	9
10	Ratna K	P	PW II	Sendang Sari Bntu	10
11	Ny. S. S. S. S. S.		Pokja II		11
12	Ny. S. S. S. S. S.	P	Pokja II	Kampung Bntu	12
13	Siti Zulfan	P	K. P. K. R. W. I. V.	Jl. Karanganyar 11/193	13
14	U. M. S. S. S. S.	P	Ket. PKK	Jl. Karanganyar 11/193	14
15	Dhuliah Wildloster	P		Kampung Bntu	15
16	Asyah	P	Sels.	Beruang Dlm Barat	16
17	Jumiatun	P	Ket. PKK	Beruang dlm btt	17
18	Sri Wanti	P	Pokja I	Jl. Karanganyar 11/193	18
19	Sri Kadarnasari	P	Ket. PKK	Jl. Karanganyar 11/193	19
20	Maskah	P	Pokja II	Jl. Gajah Timur	20
21	Eko Suro	P	Jusel	Jl. Karanganyar 11/193	21
22	Hany Astut	P	PW IX	Gajah Timur	22
23					23
24					24
25					25
26					26
27					27
28					28
29					29
30					30

3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/hari)	Uraian Tugas
1	apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm / 0615039301	STIFERA	Manajemen Farmasi	5 jam	• Membuat skema pengabdian • Menyusun proposal • Melakukan presentasi • Melakukan penyuluhan PKM • Menyusun kesimpulan • Menyusun laporan akhir • Menyusun artikel ilmiah hasil PKM
2	apt. Ferika Indrasari, S. Farm., MH	STIFERA	Manajemen Farmasi	5 jam	• Menyusun kesimpulan • Menyusun laporan akhir • Menyusun artikel ilmiah hasil PKM
3	apt. Odilia Dea CHristina, M. Farm	STIFERA	Kimia Farmasi	5 jam	• Menyusun kesimpulan • Menyusun laporan akhir • Menyusun artikel ilmiah hasil PKM
4	apt. Margareta Retno P., M.Sc	STIFERA	Biologi Farmasi	5 jam	• Menyusun kesimpulan • Menyusun laporan akhir • Menyusun artikel ilmiah hasil PKM
5	Ayu Atsna Shifa	STIFERA	DIII Farmasi	5 jam	• Melakukan presentasi • Administrasi • Dokumentasi
6	Tasya Dwi Ariyani	STIFERA	DIII Farmasi	5 jam	• Melakukan presentasi • Administrasi • Dokumentasi

4. Biodata Ketua dan Anggota

Identitas Diri (Ketua)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	apt. Eleonora Maryeta T., M. Farm
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli (AA)
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	07051973 / 5316015503930001
5	NIDN	0615039301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bajawa, 15 Maret 1993
7	E-mail	retheleonora@gmail.com / eleonorareth@gmail.com
8	Nomor Telepon/Hp	085-336-094-055
9	Alamat Kantor	Jl. Medoho III No.2, Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =...orang, S-2 =...orang, S-3 =...orang
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Farmasetika Dasar 2. Praktikum Farmasetika Dasar 3. Distribusi Farmasi 4. Praktikum Farmasetika Terapan 5. Praktikum Sistem Informasi Kefarmasian

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Setia Budi	Universitas Setia Budi
Bidang Ilmu	Farmasi Klinik	Farmasi Sains
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2015-2017
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Murbei (<i>Morus australis</i> Poir.) Terhadap Kadar HDL dan Sel Busa Tikus Putih Jantan Galur Wistar	Uji Aktivitas Fraksi-Fraksi Ekstrak Etanol Daun Murbei (<i>Morus australis</i> Poir.) Terhadap Profil Lipid Darah Dan Aterosklerosis Tikus Putih Jantan Yang Diberi Diet Tinggi Lemak dan PTU
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Gunawan Pamudji W., M. Si., apt dan Dr. Rina Herowati, M. Si., apt	Dr. Rina Herowati, M. Si., apt dan Dr. Arief Nurrochmad, M.Si., apt

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
1	2020	Evaluasi Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Dengan Metode HMN di Rumah Sakit	PT	4.250.000
2	2021	Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang <i>Beyond Use Date</i> (BUD) Obat Steril Dan Implikasi Manajerialnya Di Apotek Kimia Farma X	PT	4.250.000
3	2021	Efek Imunomodulator Senyawa Piperin Terhadap Antibodi Ig G dan Ig M Pada Tikus Galur Wistar	Kemenristek DIKTI	19.680.000
4	2023	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Obat Menggunakan Metode Hot Fit Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	PT	6.000.000

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya

C. Pengalaman Pengabdian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
1	2021	Penyuluhan Pengaruh <i>Home Pharmacy Care</i> Terhadap Penyakit Tuberkulosis Di Masa Pandemi Covid-19	PT	Rp 3.000.000
2	2023	Optimalisasi Budidaya Toga Dengan Pembuatan Biopestisida Nabati	PT	Rp 3.250.000

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1	Aktivitas Fraksi Ekstrak Etanol Daun Murbei Terhadap Profil Lipid Darah dan Aterosklerosis Tikus Yang Hiperlipidemia	Jurnal Farmasi & Sains Indonesia	Vol. 2 / No. 1 / 2019
2	Kejadian Stagnant dan Stockout Obat Kardiovaskuler Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit	Jurnal Farmasi & Sains Indonesia	Vol. 4 / No. 2 / 2021

3	Evaluasi Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Dengan Metode HMN di Rumah Sakit	Majalah Farmasetika	Vol. 8 / No. 1 / 2023
---	---	---------------------	-----------------------

E. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Panduan Praktikum Farmasetika	2021		CV. Berkah Prima
2	Buku Saku Pelayanan Kefarmasian	2023	73	Deepublish

F. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

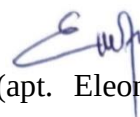
No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Evaluasi Kepuasan Pelayanan Rekonsiliasi Dengan Penerapan Sistem Informasi Di Rumah Sakit Hermina Pandanaran	2022	Buku Panduan Petunjuk	000368100 / EC 00202252367
2	Buku Saku Pelayanan Kefarmasian	2023	Buku	000470090 / EC00202337169

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan pengabdian kepada masyarakat.

Semarang, 17 Januari 2024

Pengusul,



(apt. Eleonora Maryeta T., M.
Farm)

Identitas Diri (Anggota 1)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	apt. Ferika Indrasari, S.Farm., MH
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	070715014
5	NIDN	0628058901
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Sragen, 28 Mei 1989
7	E-mail	ferikaindrasari89@gmail.com
8	Nomor Telepon/Hp	085865072117
9	Alamat Kantor	Jl. Medoho III No. 2
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =...orang, S-2 =...orang, S-3 =...orang

	S-1	S-2	S-3
Nama perguruan tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFAR) Semarang	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	-
Bidang ilmu	Farmasi	Hukum Kesehatan	-
Tahun masuk-lulus	2007 - 2014	2014 - 2015	-
Judul skripsi/tesis/disertasi	Evaluasi Penggunaan Analgetika pada Pasien Kanker Payudara di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelabelan Produk Pangan dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	-
Nama pembimbing/promotor	Dra. M. Cecillia N. SetiawatiH, M.Sc., Apt	Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM	-

A. Pengalaman Penelitian dalam Lima Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis dan Disertasi)

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (juta Rp.)
1	-	Peran Resep Elektronik dalam Meningkatkan <i>Medication Safety</i> pada Proses Peresepan di RSI Sultan Agung Semarang	Internal PT	4
2		Hubungan Kesesuaian Peresepan Obat dan Kendali Biaya Berdasarkan Formularium Nasional Pada	Internal PT	4

		Pasien BPJS Rawat Jalan di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang		
3		Analisis Implementasi TQM pada Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Nasional Diponegoro	Internal PT	4
4		The Effect Of Microwave AID Extraction Temperature Of Kedawung Leaves (Parkia biglobosa) On Antioxidant Activity And Flavonoid Leavels	Internal PT	4

B. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (juta Rp.)
1	2019	PKM Kepada Ibu-ibu PKK Kelurahan Gayamsari Semarang tentang Jenis Tanaman Beracun dan Berbahaya bagi Kesehatan	Internal PT	2,5
2	2022	<i>Indonesian herbs for healthy drinks</i> dan pelatihan pembuatan minuman herbal sebagai peningkatan imun tubuh.	Internal PT	3,25
3	2021	Penyuluhan Tentang Pola Hidup Sehat Lawan Covid-19 Dengan Umbi Lokal Sebagai Peningkat Daya Tahan Tubuh	Internal PT	3,25

C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Peran Resep Elektronik dalam Meningkatkan <i>Medication Safety</i> pada Proses Peresepan di RSI Sultan Agung Semarang	JFIKI	Vol. 7, No. 1 SI, April 2021
2	Hubungan Kesesuaian Peresepan Obat dan Kendali Biaya Berdasarkan Formularium Nasional Pada Pasien BPJS Rawat Jalan di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang	SCIENTIA	Vol. 11, No. 1 SI, Februari 2021
3	Analisis Implementasi TQM pada Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Nasional Diponegoro	JFSI	Vol. 2, No. 1 SI, Oktober 2019
4	The Effect Of Microwave AID Extraction Temperature Of Kedawung Leaves (Parkia biglobosa) On Antioxidant Activity And Flavonoid Leavels	IOP conference	755(2021) 012062, Mei 2021

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

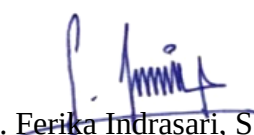
No.	Nama Temu Ilmiah/ seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Temu Ilmiah Kefarmasian: Webinar Nasional Peran Farmasis di Bidang Penelitian, Sains, Klinis dan Manajemen dalam Menghadapi Pandemi COVID-19	Analisis Biaya Pengobatan Pasien Diagnosa Gastroenteritis (Gea) Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Hermina Banyumanik	13.00-15.30 Yogya
2	Seminar Inovasi Teknologi	Peran Resep Elektronik dalam Meningkatkan Medication Safety pada Proses Peresepan di RSI Sultan Agung Semarang	Surabaya, 26 Sept 2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan pengabdian kepada masyarakat.

Semarang, 17 Januari 2024

Ketua pengabdian


apt. Ferika Indrasari, S. Farm., M.H

Identitas Diri (Anggota 2)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	apt. Odilia Dea Christina, M. Farm
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	07092099
5	NIDN	06210494
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 21 April 1994
7	E-mail	odiliadea@yahoo.com
8	Nomor Telepon/Hp	081328797078
9	Alamat Kantor	Jl. Medoho III No 2 Semarang
10	Nomor Telepon/Faks	024-6747012
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Analisis Farmasi Konvensional
		2. Kimia Organik
		3. Analisis Farmasi Instrumental
		4. Analisis obat dan makanan

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Setia Budi Surakarta	Universitas Setia Budi Surakarta
Bidang Ilmu	Farmasi , Apoteker	Farmasi
Tahun Masuk-Lulus	2012-2016	2017- 2019
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Uji Sitotoksik Ekstrak Metanol Buah Samarinda (<i>Carissa carandas</i> L.) Terhadap Sel Kanker Payudara T47d Dan Sel Vero Secara In Vitro	Uji Aktivitas ekstrak dan fraksi daun kemangi terhadap sel kanker payudara T47D dan pengaruh ekspresi gen p 53 dan bcl 2
Nama Pembimbing/Promotor	Mamik Ponco R., M.Si., Apt. Vivin Nopiyanti, M.Sc., Apt	Dr. Titik Sumarni, M. Sc Dr. Wiwin Herdwati, M. Sc

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta RP)
1	2018	Uji sitotoksik daun kemangi terhadap sel kanker payudara T47d dan sel vero	DIKTI	Rp. 8.000.000,-

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor /Tahun
1	Uji aktivitas antiarthritis ekstrak etanol biji alpukat (<i>Persea Americana</i> MIII) pada tikus jantan yang diinduksi CFA	JFSI	Vol 2 nomor 3
2	Uji sitotoksik daun kemangi terhadap sel kanker payudara T47d dan sel vero	JFSI	
3	The Effect of Basil leaf (<i>Ocinum Sanctum</i> L.) EKstract on expression of p53 and Bcl2 in T47D Breast cancer Cell	Indonesia Journal of Pharmacy	

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	The 6 th International Conference on pgharmacy and advance pharmaceutical scienes & the 3 rd Conference on pgharmacy education and research network of Sean	The Effect of Basil leaf (<i>Ocinum Sanctum</i> L.) EKstract on expression of p53 and Bcl2 in T47D Breast cancer Cell	Yogyakarta, November 14-15,2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan pengabdian kepada masyarakat.

Semarang, 17 Januari 2024

Pengusul,

(apt. Odilia Dea Christina, M. Farm)

Identitas Diri (Anggota 3)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	-
5	NIDN	0617107902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang / 17 Oktober 1979
7	E-mail	marga_rhee@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/Hp	081542341212
9	Alamat Kantor	Jl. Medoho III / 2
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 6747012
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Farmakognosi - Fitokimia
		2. Botani Farmasi
		3. Biokimia
		4. Biologi Sel dan Molekular
		5. Isolasi Bahan Alam

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sanata Dharma	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Farmasi	Obat Bahan Alam
Tahun Masuk-Lulus	1998 - 2002	2012 - 2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Uji Daya Sedatif Minyak Atsiri Rimpang Bengle (<i>Zingiber purpureum</i> , Roxb) Pada Mencit Jantan.	Pengaruh Kombinasi Daun Sambung Nyawa, Senna dan Rimpang Kunyit Terhadap Dislipidemia, Plak Aorta dan Perlemakan Hati Pada Tikus yang diinduksi PTU
Nama Pembimbing/Promotor	1. Prof. Dr. C.J Soegiharjo, Apt 2. Dr. Phebe Hendra, M.Si	1. Dr. Ika Puspitasari M.Si, Apt. 2. Dr. Arief Nurochmad, M.Si., Apt

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
1	2023	Pengaruh Perbedaan Metode Ekstraksi Terhadap Aktivitas Antibakteri Sabun Ekstrak Daun Suruhan (<i>Peperomia pellucida</i> L.) Pada <i>Staphylococcus aureus</i>	STIFERA	6.000.000,-
2	2022	Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanolik Daun Singkil (<i>Premna corymbosa</i>) Terhadap Bakteri <i>Salmonella typhi</i> Secara In Vitro	STIFERA	6.000.000,-
3	2021	Pengaruh Metode Pengeringan terhadap Kadar Flavonoid Total Ekstrak Daun Singkil (<i>Premna corymbosa</i>).	STIFERA	6.000.000,-

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1	Standardization and Phytochemical Screening of Singkil Leaf Extract (<i>Premna corymbosa</i>)	Jurnal Farmasi & Sains	2023
2	Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Jumlah Rendemen dan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Kulit Buah Markisa Kuning (<i>Passiflora edulis</i> var. <i>flavicarpa</i>)	Indonesian Journal on Medical Science	2023
3	Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kadar Total Fenolik Ekstrak Daun Singkil (<i>Premna corymbosa</i> Rottl et Wild)	Indonesian Journal on Medical Science	2022
4	Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanolik Daun Singkil (<i>Premna corymbosa</i>) Terhadap Bakteri <i>Salmonella typhi</i> Secara In Vitro	Indonesian Journal on Medical Science	2022
5	Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanolik Daun Singkil (<i>Premna corymbosa</i>)	Jurnal Ilmiah Manuntung	2022
6	Uji Daya Antiinflamasi Infusa Getah Batang Mangrove (<i>Avicennia Marina</i> (Forssk.) Vierh) Terhadap Mencit Jantan Galur Swiss Yang Diinduksi Karagenin	Jurnal Akademi Farmasi Prayoga	2021
7	In Vitro Antibacterial Activity of The Etanolic Extract of <i>Morinda citrifolia</i> L. Leaves Against <i>Stephtococcus pyogenes</i>	Journal of Pharmacy Stikes Nasional Surakarta	2020
8	Analisis Cemarkan Mikroba Pada Jamu Gendong Kunir Asem Yang Beredar di Wilayah Semarang Utara	Jurnal Akademi Farmasi Prayoga-Padang	2020

9	Aktivitas Antibakteri Ekstrak Perasan Daun Mengkudu (<i>Morinda citrifolia</i> L.) Terhadap <i>Escherichia coli</i> Secara <i>In Vitro</i>	Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia – APDFI	2020
---	---	--	------

E. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Pamflet She Jahe Serbuk Jahe Instant	2023	Hak Cipta	000477575
2	Sistem Informasi Bahan Alam (Sismiba)	2023	Hak Cipta	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan pengabdian kepada masyarakat.

Semarang, 17 Januari 2024

Pengusul,



(apt. Margareta Retno P, M.Sc)

Identitas Diri (Anggota 4)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ayu Atsna Shifa
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Status	Mahasiswa
4	NIM	A123200
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Demak, 23 Agustus 2002
6	E-mail	atsnashifa@gmail.com
7	Nomor Telepon/Hp	089681064461
8	Afiliasi	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
8	Alamat Kantor	Jl. Medoho III / 2
9	Nomor Telepon/Faks	(024) 6747012

Identitas Diri (Anggota 5)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Tasya Dwi Ariyani
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Status	Mahasiswa
4	NIM	A1232022
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 3 Februari 2003
6	E-mail	tsyadwii@gmail.com
7	Nomor Telepon/Hp	083737353483
8	Afiliasi	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
8	Alamat Kantor	Jl. Medoho III / 2
9	Nomor Telepon/Faks	(024) 6747012